FACENA - UNNE · LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Especificación de Requisitos de Software (ERS)

Sistema de Gestión de Consultorio Médico (SGC)

Estándar IEEE Std 830-1998 · Especificación rigurosa de requisitos funcionales, no funcionales, reglas de negocio, arquitectura en 4 capas, procedimientos almacenados y modelado de casos de uso.

Cátedra:	Taller de Programación II
Autores:	Nicolás Valdés, Luciano Villordo (Grupo 20)
Fecha:	Noviembre de 2026
Versión:	2.0 (Completa e integrada con SQL Server)
Repositorio:	github.com/Nicoargento11/sistema-gestion-consultorio

Contenido del Documento

1. **Introducción** (Propósito, Alcance, Definiciones, Referencias y Visión General)
2. **Descripción General** (Perspectiva, Funciones del Producto, Usuarios, Restricciones y Suposiciones)
3. **Requisitos Específicos**
    - 3.1 Interfaces Externas (Usuario, Hardware, Software y Red)
    - 3.2 Requisitos Funcionales (RF#01 a RF#28: Turnos, Pacientes, Médicos, Obras Sociales, Agenda, Ausencias, Actividad Médica, Backup y Reportes)
    - 3.3 Requisitos No Funcionales (RNF del Producto, Organizacionales y Externos)
    - 3.4 Reglas de Negocio (RN#01 a RN#06: Aranceles, Superposición, Bajas Lógicas, Integridad Referencial)
    - 3.5 Modelado de Casos de Uso (Plantillas IEEE y Diagramas según especificaciones de cátedra)
4. **Apéndices**
    - Apéndice A: Modelo de Datos y Diagrama Entidad-Relación (DER)
    - Apéndice B: Procedimientos Almacenados en SQL Server (Arquitectura de datos y optimización)
    - Apéndice C: Ciclo de Vida y Matriz de Estados de Turnos
    - Apéndice D: Matriz de Permisos por Rol

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la **Especificación de Requisitos de Software (ERS)** formal para el **Sistema de Gestión de Consultorio (SGC)**, elaborado bajo los lineamientos y estructura recomendada por el estándar internacional **IEEE Std 830-1998**. El documento tiene como propósito definir con exactitud el comportamiento funcional y técnico del software, sirviendo como contrato y referencia para la cátedra evaluadora (FACENA-UNNE), el equipo de desarrollo y el cliente operativo del consultorio.

1.2 Alcance del Producto

El sistema **SGC** es una solución de escritorio desarrollada sobre la plataforma **.NET 8 (Windows Forms)** con persistencia en **Microsoft SQL Server** mediante **Entity Framework Core** y **Procedimientos Almacenados (Stored Procedures)** nativos. Su objetivo principal es sistematizar integralmente las operaciones administrativas y de atención de un consultorio médico ambulatorio.

Procesos incluidos en el alcance:

- **Gestión de Pacientes:** Padrón único con validaciones de DNI, teléfono y cobertura médica.
- **Gestión de Médicos y Agendas:** Configuración de especialidades, aranceles de consulta, días y horarios semanales de atención, y convenios con obras sociales.
- **Gestión de Novedades y Ausencias:** Bloqueo preventivo por licencias o congresos con cancelación atómica y aviso a pacientes.
- **Asignación de Turnos Inteligente:** Cálculo de horarios libres en base a la agenda real, validación anti-superposición cruzada y duración paramétrica.
- **Recepción y Cobranza:** Registro de asistencia (Asistió/Ausente), cálculo automático de copagos según porcentaje de cobertura de obra social y liquidación en caja.
- **Módulo Médico y Registro Clínico:** Agenda personalizada del día, registro de evolución clínica (motivo, procedimiento y prescripción farmacológica) e historial cronológico confidencial.
- **Analítica y Reportes SQL:** hasta 7 reportes estratégicos (según el rol: Recepcionista y Médico) calculados dentro de la base de datos con procedimientos almacenados, visualizaciones gráficas y exportación a formato CSV.
- **Seguridad y Continuidad Operativa:** Autenticación con contraseñas encriptadas en PBKDF2 (SHA-256), roles segregados y módulo de copia de seguridad (Backup/Restore .BAK) para el Administrador.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SGC	Sistema de Gestión de Consultorio.
ERS	Especificación de Requisitos de Software (formato IEEE 830).
ABM	Alta, Baja y Modificación (CRUD) de entidades del sistema.
Baja Lógica	Inactivación de un registro mediante bandera booleana (`Activo = 0`), garantizando la integridad histórica de datos sin borrado físico.
Copago	Monto diferencial que abona el paciente en recepción cuando su cobertura médica no cubre el 100% de la consulta particular del médico.
Procedimiento Almacenado (SP)	Subrutina en lenguaje T-SQL compilada y almacenada en el motor SQL Server para ejecutar consultas analíticas y transacciones complejas con alto rendimiento.
GDI+	Graphics Device Interface de Windows utilizado para renderizar gráficos analíticos nativos de alta definición sin librerías de terceros.
PBKDF2	Password-Based Key Derivation Function 2, algoritmo criptográfico con sal y 100.000 iteraciones para almacenamiento seguro de credenciales.

1.4 Referencias

- [IEEE-830] IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998).
- [FACENA-IS1] Material de cátedra: Diagramas de Casos de Uso, Modelo de Comportamiento y ERS.
- [LEY-25326] Ley Nacional N° 25.326 de Protección de los Datos Personales (República Argentina).
- [LEY-26529] Ley Nacional N° 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud e Historia Clínica.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto y Arquitectura

El SGC opera como un sistema autónomo basado en una arquitectura multicapa desacoplada y modular. La separación de responsabilidades garantiza la mantenibilidad, escalabilidad y facilidad de auditoría:

Capa	Proyecto C#	Responsabilidad Primaria
Presentación	`SGC.UI`	Formularios Windows Forms, controles de usuario compartidos, estilos visuales (`EstiloUi`), validación inmediata de teclado y adaptación automática a DPI.
Lógica de Negocio	`SGC.Logica`	Servicios transaccionales (`TurnoService`, `PacienteService`, `BackupService`, etc.), reglas de aranceles, validaciones lógicas cruzadas y control de excepciones.
Acceso a Datos	`SGC.Datos`	Contexto de Entity Framework Core (`SGCContext`), migraciones estructuradas, configuración de restricciones CHECK a nivel motor y ejecución de Stored Procedures.
Entidades del Dominio	`SGC.Entidades`	Modelos de datos puros (POCO), enumeraciones (`RolUsuario`, `EstadoTurno`) y DTOs de reportes. Totalmente independiente de dependencias externas.



Figura 1: Diagrama de Arquitectura en 4 Capas del Sistema SGC.

2.2 Características de los Usuarios y Roles

Rol de Usuario	Perfil y Responsabilidad	Alcance Operativo
Administrador	Personal de gestión o directivo del consultorio. Familiaridad con configuraciones de software y gestión técnica.	Acceso integral a entidades maestras (médicos, obras sociales, usuarios, agendas semanales, licencias), diagnóstico del sistema y copias de seguridad (Backup/Restore). No accede a reportes, a importes ni a datos clínicos.
Recepcionista	Personal de front-desk y atención al público. Experiencia en manejo de agenda y atención de pacientes.	Gestión de pacientes, asignación y reprogramación de turnos, confirmación de asistencia, registro de cobro/copago en recepción y 7 reportes (turnos, recaudación, asistencia, ocupación, pacientes por mes, rendimiento y obras sociales) limitados a sus médicos asignados.
Médico	Profesional de la salud matriculado. Enfoque exclusivo en la atención sanitaria.	Visualización de su agenda diaria de consultas, registro de actividad clínica por turno (diagnóstico y receta), consulta del historial confidencial de pacientes y 6 reportes de su propia actividad (sin el rendimiento comparativo de médicos).

2.3 Restricciones Generales

- **Tecnología:** Plataforma .NET 8.0 Windows Forms en lenguaje C# 12.0. Base de datos SQL Server 2019/2022.
- **Persistencia de Transacciones:** Cada operación de base de datos se ejecuta en su propio contexto atómico con Entity Framework Core o llamadas seguras parametrizadas contra inyección SQL.
- **Integridad de Datos:** Prohibición estricta de bajas físicas (Hard Delete) en entidades transaccionales o de negocio; toda eliminación se implementa como baja lógica.
- **Localización:** Interfaz íntegramente en idioma español, formateo monetario en pesos argentinos (`es-AR`) y fechas estándar `dd/MM/yyyy`.

3. Requisitos Específicos

3.1 Interfaces Externas

Interfaz de Usuario: Ventana principal contenedor MDI/Panel donde las pantallas hijas se embeben dinámicamente con tamaño adaptativo, garantizando que no existan ventanas flotantes dispersas. Panel lateral interactivo con resaltado de sección activa y adaptación visual para monitores estándar y pantallas de alta densidad DPI (125% y 150%).

Interfaz de Software: Conector nativo Microsoft.Data.SqlClient y Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer contra motor SQL Server local o remoto.

3.2 Requisitos Funcionales

Subsistema 1: Gestión de Turnos y Cobranzas

ID	Requisito Funcional	Rol	Descripción Detallada
RF#01	Asignar Turno	**Recep**	El sistema debe permitir seleccionar médico, fecha, horario disponible calculado, duración (30 min por defecto) y paciente. El turno nace en estado `Confirmado`.
RF#02	Validación de Asignación	**Recep**	El sistema debe rechazar turnos en fechas/horas pasadas, fuera de la franja horaria activa del médico, dentro de un período de ausencia médica o si colisiona con otro turno confirmado del mismo médico o del mismo paciente.
RF#03	Cálculo de Horarios Libres	**Recep**	El sistema debe calcular y renderizar visualmente los bloques horarios disponibles para el médico en la fecha elegida, identificando con claridad si no hay atención por falta de agenda o por ausencia programada.
RF#04	Reprogramación de Turnos	**Recep**	Permite cambiar fecha, hora y duración de un turno confirmado sin alterar al paciente ni al médico, revalidando disponibilidad y superposiciones.
RF#05	Cancelación de Turnos	**Recep**	Permite cancelar un turno con confirmación del operador, cambiando su estado a `Cancelado` e inactivando el registro para liberar el horario.
RF#06	Confirmación de Asistencia	**Recep**	Permite registrar el ingreso del paciente a la sala de espera en el día de la fecha. Si el paciente se presentó pasa a estado `Asistió`; si faltó, pasa a `Ausente`.
RF#07	Cálculo y Cobro de Copago	**Recep**	Si el paciente asiste, el sistema sugiere automáticamente el arancel a cobrar: arancel particular si no posee cobertura o si el médico no atiende su obra social; o el arancel con descuento si la obra social tiene convenio activo.
RF#08	Notificación al Paciente	**Recep**	Al registrar, reprogramar o cancelar un turno, el sistema genera el aviso correspondiente en el centro de notificaciones para el paciente.

Subsistema 2: Gestión de Pacientes

ID	Requisito Funcional	Rol	Descripción Detallada
RF#09	Alta y Edición de Pacientes	Recep	Registro de nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico y obra social afiliada.
RF#10	Validación de Datos de Paciente	Recep	Validación de DNI numérico (7 a 8 dígitos), unicidad de documento entre pacientes activos, formato de correo con '@' y '.' y edad razonable (≤ 120 años).
RF#11	Baja Lógica de Pacientes	Recep	Inactivación del paciente impidiendo nuevas asignaciones, pero preservando turnos históricos y atenciones clínicas previas. Bloquea la baja si tiene turnos futuros confirmados.
RF#12	Búsqueda y Métrica de Paciente	Recep	Búsqueda en tiempo real por DNI, apellido o nombre, visualizando fecha de última visita, próximo turno agendado y contador de inasistencias.

Subsistema 3: Médicos, Obras Sociales y Agendas

ID	Requisito Funcional	Rol	Descripción Detallada
RF#13	ABM de Médicos	Admin	Registro de médicos con nombre, apellido, DNI, matrícula profesional única, especialidad y valor monetario de consulta particular.
RF#14	Convenio Médico - Obras Sociales	Admin	Asignación de las obras sociales aceptadas por cada profesional mediante relación muchos a muchos.
RF#15	ABM de Obras Sociales	Admin	Registro de prestatarias con nombre único y porcentaje de cobertura pactado (entre 0% y 100%).
RF#16	Configuración de Agenda Semanal	Admin	Definición de franjas horarias por día de la semana (Lunes a Domingo) con horario de inicio y fin, impidiendo solapamientos.
RF#17	Carga de Ausencias / Licencias	Admin	Registro de novedades (día completo o rango de horas) por vacaciones, congresos o enfermedad.
RF#18	Cancelación Atómica por Ausencia	Admin	Al registrar una ausencia médica, el sistema cancela en una única transacción los turnos comprometidos y emite los avisos respectivos.

Subsistema 4: Atención Médica e Historial Clínico

ID	Requisito Funcional	Rol	Descripción Detallada
RF#19	Agenda del Médico del Día	**Médico**	Visualización exclusiva de los turnos asignados al profesional logueado con tarjetas de estado (Total, Atendidos, En Espera, Cancelados).
RF#20	Registro de Actividad Clínica	**Médico**	Carga de evolución médica sobre un turno asistido: tipo de práctica (catálogo), motivo de consulta obligatorio, procedimiento diagnóstico y receta médica.
RF#21	Modificación y Baja de Atención	**Médico**	Permite rectificar la evolución o aplicar baja lógica; al eliminarse, el turno vuelve a figurar como pendiente de atención.
RF#22	Consulta de Historia Clínica	**Médico**	Explorador cronológico confidencial de evoluciones de un paciente seleccionado con filtros por rango de fechas y tipo de actividad.

Subsistema 5: Seguridad, Backups y Reportes

ID	Requisito Funcional	Rol	Descripción Detallada
RF#23	Autenticación y Control de Acceso	**Todos**	Inicio de sesión seguro; restricción estricta de formularios y vistas de datos según el rol del usuario autenticado.
RF#24	Administración de Usuarios	**Admin**	Alta y modificación de operadores; vinculación obligatoria de médicos con su perfil y asignación de médicos a recepcionistas. Protección para no desactivar al último administrador.
RF#25	Copias de Seguridad (Backup)	**Admin**	Generación de archivos de respaldo `.BAK` de la base de datos SQL Server desde la interfaz gráfica.
RF#26	Restauración de Base de Datos	**Admin**	Restauración segura desde archivo `.BAK` con verificación previa de base de datos, confirmación y ejecución automática de migraciones.
RF#27	Reportes Analíticos con Stored Procedures	**Recep** **Médico**	Ejecución de 7 reportes en base a procedimientos almacenados: Turnos por Período, Recaudación, Asistencia, Ocupación de Agenda, Pacientes por Mes, Rendimiento Médico y Distribución por Obra Social. La Recepcionista dispone de los 7, limitados a sus médicos asignados; el Médico, de 6 (sin Rendimiento Médico) sobre su propia actividad. El Administrador no accede a reportes.
RF#28	Exportación de Datos a CSV	**Recep** **Médico**	Descarga de datos tabulares calculados en formato CSV estándar compatible con Microsoft Excel con protección de caracteres de fórmula.

3.3 Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Categoría	Descripción
RNF#01	Usabilidad	Patrón visual estandarizado: formulario de captura con numeración a la izquierda, grilla de resultados con contadores arriba y franja de estado/mensajes en la parte inferior.
RNF#02	Rendimiento	Las consultas habituales de turnos y agendas deben responder en menos de 1 segundo en entorno local. Los reportes analíticos complejos se ejecutan íntegramente en SQL Server mediante Stored Procedures.
RNF#03	Seguridad / Confidencialidad	Los datos de evoluciones clínicas, diagnósticos y recetas solo son accesibles y visibles para usuarios con rol Médico. Ningún reporte administrativo expone información médica confidencial.
RNF#04	Seguridad Criptográfica	Almacenamiento de contraseñas mediante algoritmo PBKDF2 con SHA-256 y 100.000 iteraciones. Nunca se almacenan ni visualizan claves en texto claro.
RNF#05	Fiabilidad e Integridad	Persistencia atómica de transacciones y refuerzo de integridad relacional mediante claves foráneas y restricciones CHECK a nivel de motor de datos (`CK_Medico_Precio`, `CK_Turno_Monto`, etc.).
RNF#06	Compatibilidad de Pantalla	Ajuste dinámico de tipografías y contenedores para escalas de visualización de Windows al 100%, 125% y 150% (High DPI).

3.4 Reglas de Negocio (RN)

ID	Regla de Negocio	Criterio Técnico Aplicado
RN#01	Ciclo de Vida de Turno	Un turno nace exclusivamente en estado `Confirmado`. Al presentarse pasa a `Asistió`; ante inasistencia a `Ausente`; y si se cancela a `Cancelado` (con baja lógica).
RN#02	Anti-Superposición Horaria	Dos turnos colisionan si: `(Inicio_A < Fin_B) Y (Fin_A > Inicio_B)`. Turnos contiguos en el borde exacto no se consideran superpuestos. Aplica para el médico y para el paciente.
RN#03	Cálculo de Copagos	`Monto = PrecioParticular - (PrecioParticular × Cobertura / 100)` si el médico acepta la obra social del paciente; de lo contrario se factura el 100% del precio particular.
RN#04	Cancelación por Licencia	Al registrar una ausencia médica, los turnos confirmados afectados se cancelan de manera atómica con notificación al paciente.
RN#05	Protección de Integridad	No se permite dar de baja a un médico o paciente que registre turnos confirmados futuros sin reprogramar o cancelar previamente.
RN#06	Supervivencia del Administrador	El sistema rechaza cualquier intento de dar de baja lógica o despojar del rol de Administrador a la última cuenta administradora activa.

3.5 Modelado de Casos de Uso

Conforme a las pautas de la cátedra, se modelan los casos de uso principales describiendo actores, precondiciones, flujo típico, flujos alternativos y postcondiciones:

CU#01: Asignar Turno a Paciente

Campo	Detalle
Actor Principal	Recepcionista
Precondición	Sesión iniciada. Médico con agenda activa y paciente registrado en el padrón.
Flujo Principal	1. La recepcionista selecciona el médico asignado. 2. Selecciona la fecha en el calendario. 3. El sistema calcula y muestra los bloques de horarios disponibles. 4. Selecciona un horario y duración (30 min por defecto). 5. Selecciona el paciente a agendar. 6. Presiona «Asignar Turno». 7. El sistema valida reglas de negocio, guarda el turno como Confirmado y emite notificación.
Flujos Alternativos	**3a. Médico sin atención:** El sistema indica ausencia programada o día sin franja y no lista horarios. **7a. Colisión o fecha pasada:** El sistema advierte el conflicto y cancela la operación sin guardar.
Postcondición	Turno registrado en base de datos en estado Confirmado y horario ocupado en la agenda.

CU#02: Confirmar Asistencia y Cobranza

Campo	Detalle
Actor Principal	Recepcionista
Precondición	Existe un turno Confirmado para el día de la fecha o fecha anterior.
Flujo Principal	1. Selecciona el turno en la lista y presiona «Confirmar Asistencia». 2. Marca opción «Asistió». 3. El sistema calcula automáticamente el arancel a cobrar según convenio de obra social. 4. Selecciona el medio de pago (Efectivo/Particular u Obra Social). 5. Presiona «Confirmar». 6. El turno pasa a estado Asistió y queda disponible para el médico en sala de espera.
Flujos Alternativos	**2a. Paciente Ausente:** Marca «Ausente», no se solicita cobranza y el turno queda registrado como inasistencia.
Postcondición	Turno actualizado en estado Asistió con importe y medio de pago registrado.

CU#03: Registrar Atención Médica

Campo	Detalle
Actor Principal	Médico
Precondición	Médico autenticado en el sistema. El turno debe estar confirmado o con asistencia registrada.
Flujo Principal	1. El médico abre su agenda diaria y presiona «Atender Paciente». 2. Selecciona el tipo de actividad clínica (Consulta, Control, Práctica, etc.). 3. Ingresa el motivo de consulta obligatorio. 4. Registra el diagnóstico/procedimiento y prescripciones farmacológicas. 5. Presiona «Guardar Atención». 6. El sistema vincula la actividad al turno y actualiza el estado clínico.
Postcondición	Evolución clínica persistida confidencialmente e incorporada al historial del paciente.

CU#04: Generar y Restaurar Copia de Seguridad (Backup/Restore)

Campo	Detalle
Actor Principal	Administrador
Precondición	Sesión iniciada con credenciales de Administrador. Acceso a SQL Server.
Flujo Principal	1. Ingresa a la sección «Copia de Seguridad». 2. Para crear: Selecciona carpeta de destino y presiona «Crear copia ahora». El sistema ejecuta el backup nativo. 3. Para restaurar: Selecciona archivo .BAK válido, el sistema verifica cabeceras de base de datos y solicita confirmación de seguridad. 4. Se bloquea la navegación, se restaura la base y se aplican migraciones pendientes.
Postcondición	Base de datos respaldada o restaurada a su estado operacional íntegro.

4. Apéndices

Apéndice A: Modelo de Datos y DER

El modelo relacional del SGC se encuentra normalizado en tercera forma normal (3FN) e implementado sobre SQL Server con Entity Framework Core. Las claves primarias utilizan identificadores enteros autonuméricos (Identity), resguardando unicidad lógica con índices únicos (DNI, Matrícula, Nombre de Usuario).

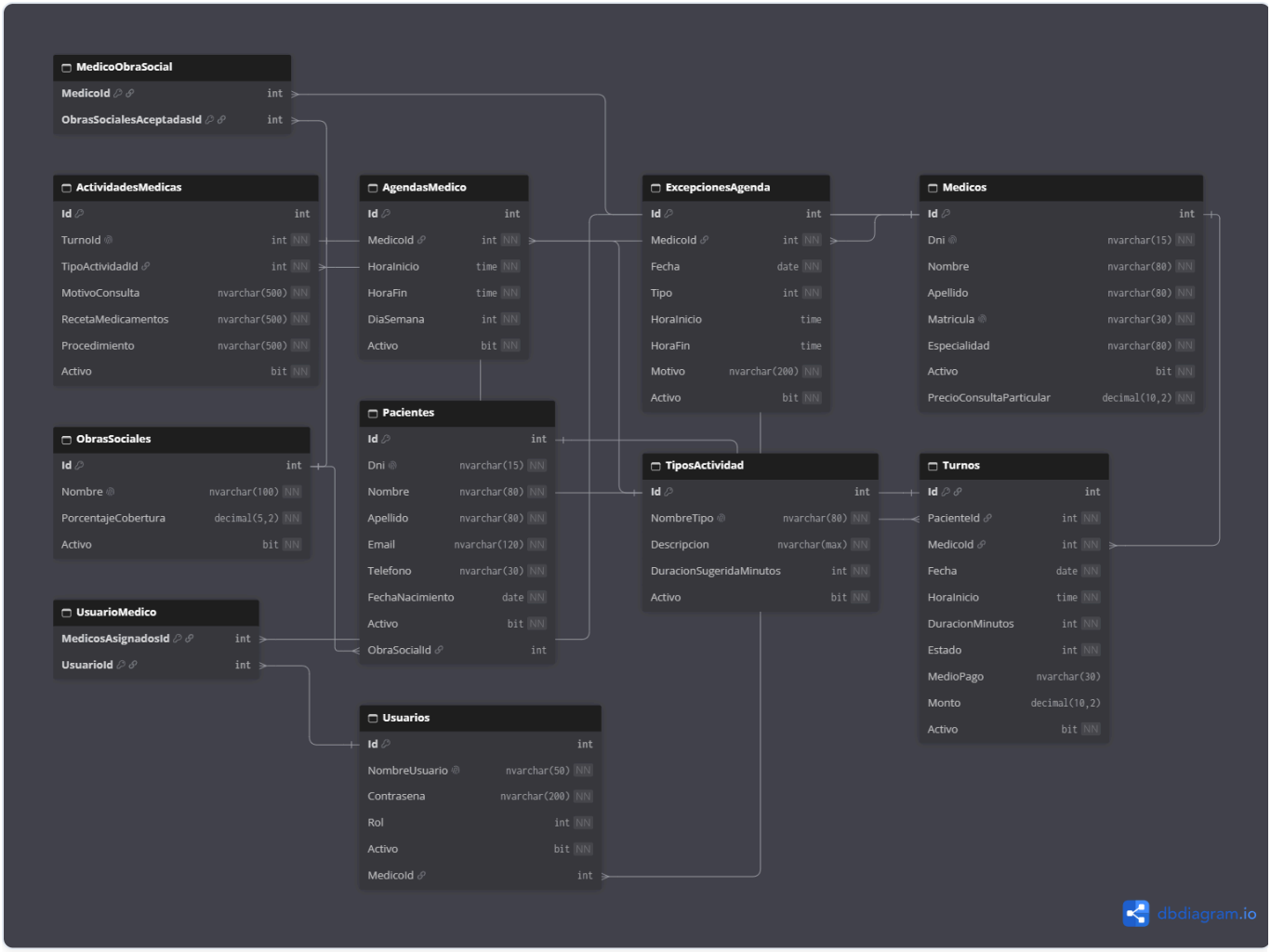


Figura 2: Diagrama de Entidad-Relación (DER) de la Base de Datos SGC.

Apéndice B: Procedimientos Almacenados en SQL Server

A diferencia de sistemas que procesan grandes volúmenes de datos en memoria cliente, el SGC traslada la lógica pesada de cálculo, agregación y reportería directamente al motor de base de datos mediante Stored Procedures nativos:

Procedimiento Almacenado	Parámetros	Propósito y Optimización
`sp_ObtenerTurnosPorMedicoYFecha`	@MedicoId, @Fecha, @IncluirCancelados	Recupera los turnos del médico optimizando el filtrado en el motor y materializando relaciones en C#.
`sp_AsignarTurno`	@PacienteId, @MedicoId, @Fecha, @HoraInicio, @DuracionMinutos	Valida agenda, vigencia y solapamiento horario en una transacción atómica directa en SQL Server.
`sp_ReporteTurnosPorPeriodo`	@FechaDesde, @FechaHasta, @MedicoId, @Estado	Lista los turnos de un rango de fechas con filtros opcionales de médico y estado.
`sp_ReporteRecaudacion`	@FechaDesde, @FechaHasta, @AgruparPor, @MedicoId	Totaliza lo facturado en un período, agrupado por médico, medio de pago u obra social.
`sp_ReportePacientesPorMes`	@Anio, @MedicoId	Agrupa atenciones mensuales con sumatorias condicionales (Atendidos, Ausentes, Cancelados) según el rol.
`sp_ReporteTurnosPorObraSocial`	@Anio, @MedicoId	Calcula volumen de turnos y recaudación total por obra social con soporte de filtro médico.
`sp_ReporteRendimientoMedicos`	@Anio, @Mes, @MedicoId	Genera matriz comparativa de desempeño profesional (turnos otorgados, tasa de atención y facturación).
`sp_ReporteAsistencia`	@FechaDesde, @FechaHasta, @MedicoId	Calcula porcentajes y totales de asistencia efectiva vs. ausentismo en un período.
`sp_ReporteOcupacionAgenda`	@FechaDesde, @FechaHasta, @MedicoId	Compara horas de turno ocupadas contra la capacidad máxima de la agenda médica semanal.
`sp_ResumenDelDia`	@Fecha, @MedicoId	Alimenta el panel de inicio con las métricas del día y de la semana, filtradas por médico cuando corresponde.

Apéndice C: Ciclo de Vida y Estados del Turno

Estado	Significado	Transición y Responsable
Confirmado	Turno activo programado en agenda.	Estado inicial de creación (Recepcionista / RF#01).
Asistió	El paciente se presentó al consultorio y se registró el cobro.	Confirmación de asistencia en recepción (Recepcionista / RF#06).
Ausente	El paciente faltó a su cita programada.	Registro de inasistencia (Recepcionista / RF#06).
Cancelado	Turno cancelado por el paciente o por licencia médica.	Baja lógica del turno (Recepcionista o Administrador / RF#05, RF#18).

Apéndice D: Matriz de Permisos por Rol

Módulo / Funcionalidad	Administrador	Recepcionista	Médico
Pantalla de Inicio y Resumen	Sí (Estado del Sistema)	Sí (Turnos de sus médicos)	Sí (Mi día y próximo paciente)
Padrón de Pacientes	No	Sí (Completo)	No
Gestión de Turnos y Cobros	No	Sí (Médicos asignados)	No
Médicos, Obras Sociales y Agendas	Sí (Completo)	No	No
Ausencias y Licencias Médicas	Sí (Completo)	No	No
Gestión de Usuarios y Roles	Sí (Completo)	No	No
Copia de Seguridad y Restauración	Sí (Completo)	No	No
Mi Agenda del Día	No	No	Sí (Propia)
Evolución Clínica y Recetas	No	No	Sí (Propia)
Historial Clínico del Paciente	No	No	Sí (Solo lectura)
Reportes y Estadísticas	No	Sí (7 reportes, de sus médicos asignados)	Sí (6 reportes, propios)